

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093421-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ELDECIR MARINHO DA SILVA

MEDIDA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR PARA ENCAMINHAR A PARTE AUTORA PARA A PRIMEIRA CONSULTA EM HEMATOLOGIA -ONCOLOGIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. LIMINAR RATIFICADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de modo a ratificar a decisão anteriormente proferida. Sem condenação em honorários, considerando a natureza do presente recurso. Publique-se e intím-se. Com o trânsito em julgado, archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5093421-47.2024.4.02.5101

510015353144 .V7

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093421-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ELDECIR MARINHO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela **UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO** em face da decisão que deferiu a tutela de urgência, nos autos originários, determinando imediato encaminhamento da parte autora a tratamento oncológico, considerando o diagnóstico de doença grave da parte autora ("*mieloma múltiplo e neoplasias malignas nas vértebras C3, C4 e C6 (CID C 90)*").

A decisão (Evento 03) indeferiu a liminar.

A parte autora apresentou contrarrazões (Evento 10).

É o breve relatório.

VOTO

No caso, não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão, a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União em face da decisão proferida no processo 5010659-20.2024.4.02.5118/RJ, evento 3, DESPADEC1, verbis:

"Trata-se de ação ajuizada por ELDECIR MARINHO DA SILVA em face da UNIÃO, MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO e ESTADO DO RIO DE JANEIRO objetivando "que os réus sejam condenados a fornecer TRATAMENTO ONCOLÓGICO, conforme laudo e exames médicos em anexo, bem como os demais procedimentos necessários no decorrer do tratamento a fim de que a doença seja estabilizada". Pleiteia a concessão de tutela de urgência.

Inicial e documentos anexados ao Evento 1.

É o relatório. DECIDO.

Narra a parte autora que possui diagnóstico de **mileoma múltiplo** e **neoplasias malignas nas vértebras C3, C4 e C6 (CID C 90)**, **moléstia extremamente agressiva**, pois desenvolve em **velocidade células plasmáticas da medula óssea**, causando a **produção excessiva de proteínas anormais** e a **formação de tumores ósseos**, ocasionado **intensas dores**. E que no caso do autor a **doença atingiu a coluna** e ele **tem sofrido com as dores**, impossibilitando inclusive a sua **locomção estando atualmente acamado e bem debilitado**.

Afirma que **"após a realização de biópsia foram localizadas lesões em toda a extensão da coluna C3, C4 e C6, ou seja, mielomia múltipla, sendo necessário iniciar o tratamento oncológico com extrema urgência"**.

Dispõe o art. 2º da Lei 12.732/2012 que **"O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único"**.

Com efeito, o prazo máximo de 60 dias previsto para início do tratamento oncológico no artigo 2º da Lei nº 12.732/12 pode, ainda, ser reduzido em caso de necessidade terapêutica registrada em prontuário.

No caso dos autos, o laudo emitido por médica do SUS que atendeu o autor evidencia a urgência do atendimento médico oncológico, tendo sido indicado que o autor apresenta lesões císticas em toda a extensão da coluna e registrado expressamente que o encaminhamento para atendimento oncológico é urgente:



PREFEITURA DE
Belford Roxo
UMA NOVA CIDADE, COM NOVAS OPORTUNIDADES.

Secretaria de
SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 12.185.438/0001-20
CHES - 74
Endereço: Rua Guizot, 125, Belford Roxo - Belford Roxo - RJ
CEP: 26.167-400

GUIA REFERÊNCIA
"urgente"

DO MUNICÍPIO B. Roxo PARA UNIDADE _____

NOME: Eldecir Marinho da Silva

IDADE: 55 anos PRONTUÁRIO: _____

A SERVIÇO DE: Ampliação de Oncologia

MOTIVO DE ENCAMINHAMENTO:
PO biópsia + laminectomia C3, C4 e C6
lesões císticas em toda extensão da coluna
Mieloma múltiplo?

Dra. Michelle Martins
Medica
CRM: 52.0116926-2

15/10/24

Assinatura/Carimbo

Data

CONTRAREFERÊNCIA

CONDUTA: _____

O exame histopatológico de 21/08/2024 comprova o diagnóstico de neoplasia plasmocitária:

RA: 46616840 - ELDECIR MARINHO DA SILVA 1788/24 55 ano(s) **Sexo : M**

Dr.(a): NI - NÃO INFORMADO

Entrada: 21/08/2024 15:18:27

Unidade: CMC-COMPLEXO MIGUEL COUTO - **Posto:** 000002 - **HOSPITAL MIGUEL COUTO**

Prontuário: 592277 **Cód.SUS:** Local de

Entrega: 000009-ANATOMIA - **HOSPITAL MIGUEL COUTO**

Coleta: 21/08/2024 15:18:00

IMUNOHISTOQUÍMICO

Marcador	Resultado
CD20	Negativo.
CD56	Positivo.
CD138	Positivo.
Kappa	Negativo.
Lambda	Positivo.

Conclusão:
Biópsia de lesão óssea. Localização C3 e C6.
O conjunto do quadro histopatológico em associação ao quadro imuno-histoquímico é compatível com presença de neoplasia plasmocitária, com restrição de lambda (cadeia leve de imunoglobulinas), imunoexpressão acima relatada.

Ademais, o ofício da Subsecretaria de Atenção à Saúde juntado ao Evento 1 - OFIC8 evidencia que a regulação do autor está pendenciada desde 29/10/2024 em razão da necessidade de alteração do recurso solicitado para Hematologia - Oncologia. Confirma-se a informação prestada:



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria de Atenção à Saúde

À Subsecretaria de Atenção à Saúde/SES.

Trata-se do Ofício nº 7549239/2024 - DTS BAIXADA, PAJ (DPU): 2024/064-02410, datado de 29/10/2024, em favor do paciente ELDECIR MARINHO DA SILVA, diagnosticado com Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos e necessita de tratamento oncológico.

Na data de hoje (29/10/2024), através de consulta junto ao Sistema Estadual de Regulação – SER, a fim de atender esta demanda, a REUNI-RJ informa que, o referido paciente, inserido em 25/10/2024, encontra-se na 57ª posição da fila Ambulatório 1ª vez - Tumores do Tecido Ósseo e Conectivo (Adulto), de um total de 64 pacientes para a solicitação em questão. Entretanto, a solicitação foi pendenciada no dia 29/10/2024, pois a Unidade solicitante (Gestor SMS Belford Roxo) deve trocar o recurso para Hematologia - Oncologia (pois Mieloma é patologia de competência hematológica), para prosseguirmos com a regulação do paciente.

Vale informar que o Complexo Estadual de Regulação do Rio de Janeiro regula apenas o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS às unidades de saúde, direcionando os seus pacientes ao melhor recurso disponível no momento, visando garantir a equidade aos cidadãos dos 92 municípios do Estado. Viabilizamos o acesso à Consulta de 1ª vez. Uma vez admitido pela unidade de saúde, a conduta a ser seguida e a programação terapêutica aplicada ao caso de cada indivíduo é de inteira responsabilidade da unidade que o admitiu.

O paciente pode consultar sua posição na fila através do Painel Público do Complexo Estadual de Regulação, acessando o site <https://painel.saude.rj.gov.br/PainelRegulacao/regulacaoestadual.html> e clicando na aba "Lista de Espera Ambulatorial".

Sendo assim, encaminhamos o presente expediente para ciência e prosseguimento do mesmo e nos colocando à disposição para quaisquer maiores informações.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2024

Ou seja, no caso concreto, além da gravidade do quadro clínico do paciente, ocorreu falha na solicitação de regulação, que obstou a inclusão do autor em fila para o recurso correto e, assim, inviabilizou o seu acesso ao tratamento adequado do qual necessita com urgência, conforme necessidade terapêutica registrada em laudo emitido por médica do SUS.

Por meio da Portaria nº 874 de 16 de maio de 2013, encontra-se instituída, no âmbito do SUS, a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, que tem como objetivo a redução da mortalidade e da incapacidade causadas pela doença, preconizando toda política pública necessária e, ainda, que o tratamento aos pacientes com câncer se dará por meio de Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON/CACON).

No caso vertente, portanto, todo tratamento necessário para a doença de câncer que aflige a parte autora, deve ser-lhe garantido, através das Unidades credenciadas como UNACON/CACON (cf. Portaria MS nº 140, de 27 de fevereiro de 2014).

Consoante se extrai da Constituição Federal de 1988, à Saúde foi dispensado o status de direito social fundamental (art. 6º), atrelado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, consubstanciando-se em “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196).

Dispõe, ainda, o § 1º do art. 198 da Carta Magna que “O sistema único de saúde será financiado, em termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes”.

Outrossim, a responsabilidade do Estado (lato sensu) em relação à garantia do direito à saúde, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que, em Sessão Plenária, firmou o entendimento no sentido de ser possível a intervenção judicial nas políticas públicas atinentes a esse direito e definiu, após audiência pública, critérios e parâmetros para a análise das demandas de saúde, a fim de que não haja indevida interferência do Judiciário nas políticas a cargo dos demais Poderes, bem como não permaneça, por outro lado, indiferente diante de situações de graves ofensas ao direito à saúde. Estabeleceu, ademais,

tratar-se de obrigação solidária repartida entre todas as esferas de governo, razão pela qual União, Estados e Municípios são legitimados passivos em demandas dessa espécie, em litisconsórcio facultativo. Nesse sentido:

EMENTA: Suspensão de Liminar. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde- SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. (SL 47 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00001)

Com relação à natureza solidária da obrigação Estatal de oferecer as prestações de saúde à população brasileira e, ainda, sobre a possibilidade de o Poder Judiciário adotar as providências cabíveis para concretização desse direito, no exercício de suas atribuições constitucionais, sem que isso implique em violação à separação de Poderes, não subsistem maiores dúvidas no estágio atual da jurisprudência pátria. Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. INAPLICÁVEL A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS DIVERSOS. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.11.2012. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Diversos os temas discutidos no extraordinário e no paradigma apontado (RE 566.471-RG), inaplicável a sistemática da repercussão geral. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 793319 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.06.2014)

Como se observa, existe sólida e amplamente majoritária corrente jurisprudencial acolhendo a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas envolvendo prestações de saúde no âmbito do SUS, assim como a possibilidade de o Judiciário deliberar a respeito, quando identificado o descumprimento ou atuação estatal insuficiente, relativamente ao direito fundamental à saúde, sem que essa atuação implique em violação à separação de poderes, reserva do possível ou normas orçamentárias. Do contrário, restaria conferida ao administrador a possibilidade de fazer tábula rasa da proteção à saúde delineada pelo Constituinte.

É importante consignar que o magistrado, quando exerce seu mister em demandas referentes às políticas públicas de saúde, não o faz de forma a substituir-se ao administrador, mas sim no exercício da função constitucional que lhe foi atribuída, nas hipóteses em que é indispensável para garantir o direito à vida e à saúde, evitando, com isso, a ocorrência de graves danos a direitos fundamentais e, inclusive, a incidência de óbitos de jurisdicionados, como tem sido, inclusive, observado em algumas hipóteses, mas que talvez pudessem ser evitados pela atuação tempestiva do Poder Judiciário.

No presente caso a documentação acostada à inicial evidencia a urgência do quadro de saúde da parte autora e a necessidade de encaminhamento urgente da autora para tratamento oncológico adequado, o que enseja o deferimento da tutela de urgência requerida.

O direito à vida e à saúde é o mais fundamental direito do ser humano, pois é a base, o antecedente, o pressuposto, a condição indispensável para o exercício de qualquer direito. Por isso, o direito à vida e à saúde não pode ser relegado ao possível, ao conveniente, ao oportuno, à conjuntura econômica e financeira. É direito que, em decorrência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve prevalecer sobre o mero interesse financeiro das Pessoas Jurídicas de Direito Público.

Assevero, por fim, que descabe o direcionamento pelo juízo para atendimento da autora em hospital específico, sendo certo que, na hipótese, o que é assegurado pela lei é o atendimento da autora através das Unidades credenciadas como UNACON/CACON.

*Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os réus, solidariamente, que informem unidade credenciada da rede pública com disponibilidade para realizar a primeira consulta em Hematologia - Oncologia da parte autora no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da presente decisão, bem como para iniciar o tratamento oncológico que se mostrar indicado, conforme avaliação que será feita pela equipe médica especializada em Hematologia - Oncologia responsável pelo atendimento (seja radioterapia, quimioterapia, cirurgia ou outro tratamento que se mostre indicado) no prazo de até 10 (dez) dias da consulta realizada, **forneendo referido tratamento enquanto for necessário ao restabelecimento da saúde da autora**, sob pena multa diária que fico em R\$200,00 (duzentos reais) para cada réu, limitada a R\$5.000,00 (cinco mil reais) para cada réu. **Intimem-se os réus para cumprimento com urgência.***

Intime-se a Central de Regulação de Vagas do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa de seu representante, para dar imediato cumprimento à presente decisão, devendo tomar todas as providências cabíveis no sentido de indicar a Unidade integrante da

Rede de Atenção em Alta Complexidade do Estado do Rio de Janeiro apta à realização do primeiro atendimento e do tratamento em Hematologia - Oncologia do autor.

Intime-se a parte autora para ciência da presente decisão, bem como para que informe ao juízo, no prazo de 10 dias, acerca de eventual descumprimento da tutela deferida.

Sem prejuízo, cite-se a parte ré.

Publique-se. Intimem-se."

A União aduziu a carência de requisitos para a tutela provisória de urgência, bem como a ofensa ao princípio da isonomia, a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a necessidade de direcionamento ao Estado ou Município. Requereu o direcionamento do cumprimento da ordem judicial ao Estado; a redução do valor da multa para quantia não superior a R\$ 100,00 diários e limitada ao teto máximo de R\$ 2.000; o estabelecimento de 30 dias dias como termo inicial de incidência da multa cominatória por eventual descumprimento da ordem judicial.

É o breve relatório.

Sabe-se que são requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

A parte autora comprovou os requisitos.

A parte autora comprovou ter diagnóstico de mieloma múltiplo e neoplasias malignas, por meio do exame histopatológico datado de 21/08/2024.

Os documentos juntados, assinados por médicos da rede pública de saúde, comprovaram que há urgência no seu tratamento.

Solicitações de Consulta ou Exame									
ID #	Tipo #	Recurso #	Data de Solicitação #	NI #	Paciente #	Idade #	CID #	Agendado para	Situação #
6027035	CONSULTA	Ambulatorio 1ª Vez - Tumores do Tórax, Ovario e Conectivo (Adulto)	25/10/2024	7000046731436.07	ELDECIR MARINHO DA SILVA	55 anos(a), 11 meses e 5 dias(s)	G20 - (C20) Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos		Em fila
Exportar para Excel									

**PREFEITURA DE
Belford Roxo**
UMA NOVA CIDADE, COM NOVAS OPORTUNIDADES.

Secretaria de
SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 12.185.478/0001-20
SUA: 12.185.478/0001-20
Endereço: Rua Lacerda, 135, Centro - Belford Roxo - RJ
CEP: 26.167-400

GUIA REFERÊNCIA
"urgente"

DO MUNICÍPIO B. Roxo PARA UNIDADE _____

NOME: Eldecir Marinho da Silva

IDADE: 55 anos PRONTUÁRIO: _____

A SERVIÇO DE: Ambulatório de Oncologia

MOTIVO DE
ENCAMINHAMENTO: PO diagnóstico + laminectomia C3, C4 e C6
lesões líticas em toda extensão da coluna
Mieloma múltiplo?

Dra. Michelle Martins
Médica
CRM: 52.0116926-2

15/10/24

Assinatura/Carimbo Data

O documento emitido pela Secretaria do Estado de Saúde afirmou que o atendimento da parte autora foi procrastinado em razão dos entraves burocráticos experimentados no momento da regulação do paciente.



À Subsecretaria de Atenção à Saúde/SES.

Trata-se do Ofício nº 7549239/2024 - DTS BAIXADA, PAJ (DPU): 2024/064-02410, datado de 29/10/2024, em favor do paciente ELDECIR MARINHO DA SILVA, diagnosticado com Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos e necessita de tratamento oncológico.

Na data de hoje (29/10/2024), através de consulta junto ao Sistema Estadual de Regulação – SER, a fim de atender esta demanda, a REUNI-RJ informa que, o referido paciente, inserido em 25/10/2024, encontra-se na 57ª posição da fila Ambulatório 1ª vez - Tumores do Tecido Ósseo e Conectivo (Adulto), de um total de 64 pacientes para a solicitação em questão. Entretanto, a solicitação foi pendenciada no dia 29/10/2024, pois a Unidade solicitante (Gestor SMS Belford Roxo) deve trocar o recurso para Hematologia - Oncologia (pois Mieloma é patologia de competência hematológica), para prosseguirmos com a regulação do paciente.

Vale informar que o Complexo Estadual de Regulação do Rio de Janeiro regula apenas o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS às unidades de saúde, direcionando os seus pacientes ao melhor recurso disponível no momento, visando garantir a equidade aos cidadãos dos 92 municípios do Estado. Viabilizamos o acesso à Consulta de 1ª vez. Uma vez admitido pela unidade de saúde, a conduta a ser seguida e a programação terapêutica aplicada ao caso de cada indivíduo é de inteira responsabilidade da unidade que o admitiu.

O paciente pode consultar sua posição na fila através do Painel Público do Complexo Estadual de Regulação, acessando o site <https://painel.saude.rj.gov.br/PainelRegulacao/regulacaoestadual.html> e clicando na aba "Lista de Espera Ambulatorial".

Sendo assim, encaminhamos o presente expediente para ciência e prosseguimento do mesmo e nos colocando à disposição para quaisquer maiores informações.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2024

Assim, enquanto a parte autora aguarda o devido tratamento para a sua enfermidade, o tempo decorrido acarreta agravamento do quadro clínico e aumento da possibilidade de evolução para óbito.

Presentes, portanto, o periculum in mora e o fumus boni juris.

Quanto à argumentação sobre a necessidade de observância de critérios isonômicos na organização da fila de espera pela Administração, o princípio da impessoalidade, garantidor da isonomia alvejada nas respostas institucionais às demandas trazidas pela população, não pode servir de justificativa para relativizarem-se peculiaridades individuais no importe de sofrimento desproporcionalmente majorado ou de normalização da precariedade/morosidade na prestação dos serviços públicos.

No que toca à irreversibilidade dos efeitos de uma possível decisão satisfativa tomada neste momento, calha ressaltar que a não concessão da tutela antecipada teria efeitos muito mais graves, deletérios e permanentes do que a eventual despesa financeira que o Poder Público possa ter.

*Quanto ao tema, cabe mencionar o enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil, que assim dispôs: "**ENUNCIADO 40** - A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível."*

Portanto, afigura-se mais adequado para solucionar o conflito entre o direito à saúde e a capacidade orçamentária do Poder Público, que a transferência hospitalar seja realizada.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela.

O Tema 793, estabeleceu que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (RE 855178, em 23.05.2019).

Na mesma direção, os enunciados 8, 60, 87 CNJ trataram, respectivamente, do respeito à repartição de competências entre os entes, da necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação a um dos entes e da individualização da atribuição dos entes.

No caso, a lei assegura o atendimento através das Unidades credenciadas como UNACON/CACON, sendo correto o entendimento de que os réus, solidariamente, deverão informar qual a unidade credenciada da rede pública com disponibilidade para realizar a primeira consulta em Hematologia - Oncologia.

Do exposto, voto por indeferir o requerimento de natureza cautelar de atribuição de efeito suspensivo.

Após, à conclusão para voto.

Publique-se. Intime-se."

Por todo o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**, de modo a ratificar a decisão anteriormente proferida. Sem condenação em honorários, considerando a natureza do presente recurso. Publique-se e intemem-se. Com o trânsito em julgado, archive-se.

5093421-47.2024.4.02.5101

510015353143 .V5